# 혈압약, 왜 사람마다 다를까요

혈압을 낮추는 약은 여러 종류입니다. 효과와 주의할 증상을 함께 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 혈압약 선택에 중요한 세 가지

어떤 약을 쓸지는 동반 질환과 부작용을 함께 보고 정합니다.

1

## 약 종류는 함께 앓는 병으로 고릅니다

혈압약 종류끼리 평균적인 혈압 감소 폭은 비슷합니다. 심부전·단백뇨·심장혈관병·빠른 맥박 등 함께 앓는 병과 주의사항에 맞춰 고릅니다.

같은 종류여도 약마다 하루 동안 효과가 이어지는 시간이 다릅니다.

**함께 앓는 병 → 약 종류**

2

## 증량보다 2제 병용

한 약의 용량을 2배로 늘리면 추가 효과는 약 20%에 그칩니다. 다른 종류를 함께 쓰면 추가 효과가 약 5배 큽니다.

대부분은 서로 다른 두 약으로 시작할 수 있습니다.

**약을 더할지는 의사와 상의**

3

## 금기 조합 두 가지

혈압을 올리는 호르몬을 막는 두 계열의 약은 함께 쓰지 않습니다. 맥박을 늦추는 약 두 종류를 함께 쓰면 맥박이 너무 느려질 수 있습니다.

임신 중에는 호르몬 억제약을 쓰지 않습니다.

**처방 전 병용약 확인**

실천 · 혈압 수치와 다른 질환을 함께 알려 주시면 약을 고르는 데 도움이 됩니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 약을 두 가지 이상 쓰는 이유

한 약을 계속 늘리는 것보다 다른 방식의 약을 더하는 편이 나을 수 있습니다.

1

## 두 가지 약부터

혈압 호르몬을 막는 약에 혈관을 넓히거나 소변을 늘리는 약을 더할 수 있습니다. 한 알 복합제로 먹기도 합니다.

**대부분 환자에서 시작**

2

## 세 가지 약

호르몬 억제약 + 혈관 확장약 + 이뇨제를 함께 씁니다. 한 알 복합제를 우선합니다.

**용량 최적화 확인**

3

## 네 번째 약이 필요한 경우

세 가지 약을 적절히 써도 높다면 복용·측정 문제부터 확인합니다. 콩팥 기능과 칼륨을 본 뒤 스피로노락톤 25~50 mg/일을 의사가 검토할 수 있습니다.

**비교 연구 근거**

4

## 적응이 있으면 베타차단제

심장 힘이 약한 심부전, 관상동맥질환, 심방세동의 맥박 조절, 빠른 맥박이 있으면 베타차단제를 함께 쓸 수 있습니다.

**함께 앓는 병 우선**

**위험이 낮은 1기 고혈압이거나 고령·허약한 분은 한 가지 약으로 시작할 수 있습니다**

실천 · 약을 늘리기 전 집에서 잰 혈압과 실제 복용 여부를 확인하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 세 가지 약을 먹어도 높다면, 먼저 원인을 찾습니다

복용한 약·집에서 잰 혈압·생활습관을 함께 보면 다음 치료를 정할 수 있습니다

### 측정이 맞는지

팔에 맞는 커프로 바르게 측정합니다. 가정혈압이나 활동혈압검사로 병원에서만 높아지는지 살핍니다.

### 실제로 먹은 약

약 이름·용량·빠뜨린 날을 알려 주세요. 한 알 복합제로 복약을 정리하는 방법도 의사가 검토합니다.

### 생활과 다른 약

소염진통제·감기약·감초가 든 약, 염분 섭취를 점검합니다. 코골이와 수면무호흡도 함께 살핍니다.

### 전문 검사와 약 조정

안지오텐신계 약·칼슘통로차단제·이뇨제 세 약을 써도 높으면 전문 진료를 받습니다. 칼륨·콩팥 기능과 알도스테론 등 이차성 원인을 평가합니다.

연자 Q&A · 추가 약은 검사 결과에 맞춰 의사가 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 추가 약을 고르기 전에 검사와 조정이 이어집니다

연자 Q&A · 조절이 어려운 고혈압에서는 전문의가 순서대로 검토합니다

1

### 이뇨제부터 점검

현재 이뇨제의 종류와 용량이 알맞은지 보고, 콩팥 기능에 맞춰 조정합니다. 약을 스스로 더하지 마세요.

2

### 추가 약의 안전성

스피로놀락톤 또는 아밀로라이드 등을 검토할 때 칼륨과 콩팥 기능을 확인합니다.

3

### 계속 높다면 전문 평가

추가 강압에는 ARNI 계열로 바꾸는 방법도 검토합니다. 이차성 원인 검사와 약 조정을 함께 진행합니다.

현재 약 점검 → 피검사·원인 평가 → 전문의와 조정

호흡곤란이나 부종이 있으면 심부전 동반 여부도 평가합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 혈압약은 서로 다른 길로 작용합니다

혈관을 넓히거나, 소금 배출을 늘리거나, 심장의 일을 줄입니다.

### 혈압 호르몬을 막는 약

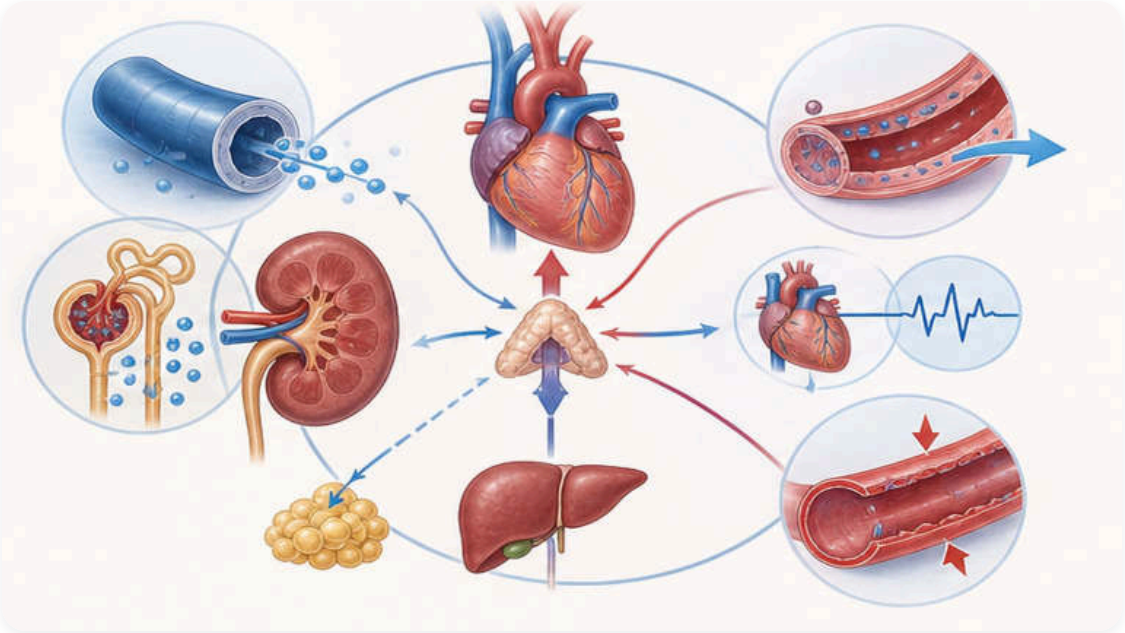
혈압을 올리는 호르몬의 작용을 막습니다. 한 종류는 마른기침이 생길 수 있고, 다른 종류는 기침이 드뭅니다.

### 칼슘차단제는 두 방식

한 종류는 혈관을 넓히고, 다른 종류는 맥박도 늦춥니다. 맥박을 늦추는 다른 약을 먹는다면 함께 알려 주세요.

### 나트륨 배설 · 교감 차단

티아지드 계열은 소금 배출을 늘리고, 알도스테론 차단 이뇨제(스피로노락톤 등)는 알도스테론이라는 호르몬을 막습니다. 베타차단제는 맥박과 심장의 일을 줄입니다.



**기전이 다른 두 약을 더하면 서로의 보상 반응을 막아 효과가 커집니다**

실천 · 이름이 비슷한 혈압약을 임의로 함께 드시지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 같은 종류라도 복용법이 다릅니다

같은 종류(ARB) 약은 효과가 대체로 비슷하고, 직접 비교에서 조금 더 강한 것은 아질사르탄 하나입니다.

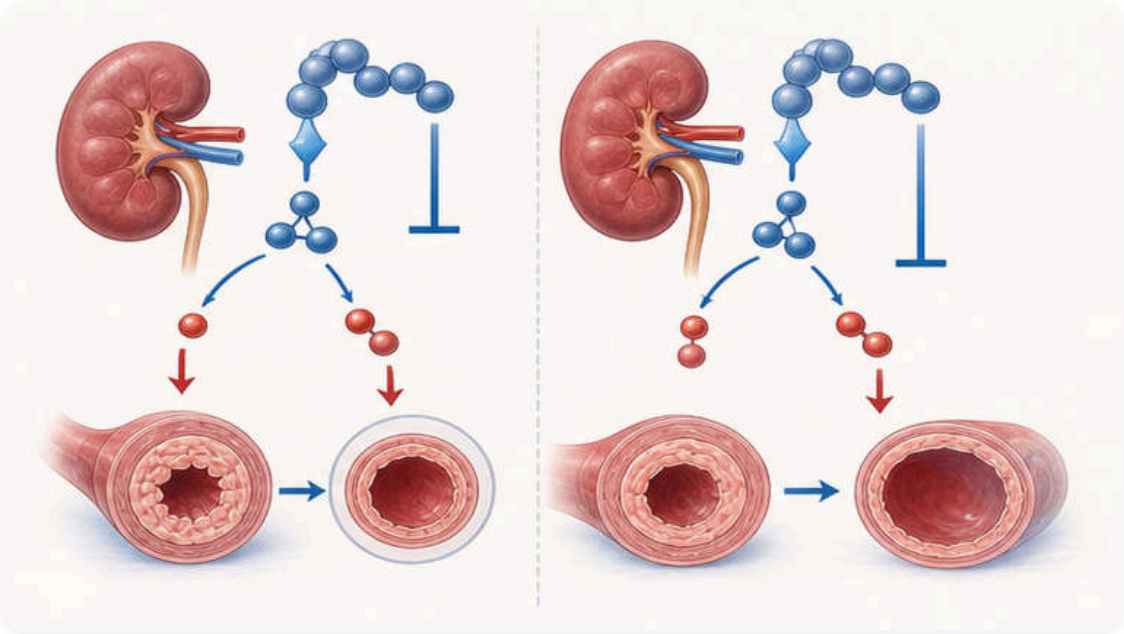
| 약 종류 | 어떻게 다른가요? | 무엇을 살펴볼까요? |
|---|---|---|
| **호르몬 억제약 (ARB)** | 대체로 비슷함 · 직접 비교에서 아질사르탄만 조금 더 강함 | 집에서 잰 혈압과 복용 시간을 알려 주세요. |
| **호르몬 억제약 (ACE 억제제)** | 혈압을 낮추는 효과는 비슷하지만 마른기침이 더 흔할 수 있습니다. | 기침이 계속되면 의사에게 알려 주세요. |
| **혈관을 넓히는 약** | 종류에 따라 발목 붓기가 달라질 수 있습니다. | 붓기가 심하면 의사가 약을 바꿀 수 있습니다. |
| **맥박도 늦추는 약** | 혈관을 넓히면서 심장 박동도 늦춥니다. | 맥박이 느려지거나 어지러우면 알려 주세요. |
| **소변을 늘리는 약** | 약마다 작용이 이어지는 시간이 다릅니다. | 피검사로 칼륨을 확인할 수 있습니다. |
| **심장의 일을 줄이는 약** | 약마다 혈관을 넓히는 정도도 다릅니다. | 피로와 맥박 변화를 기록해 주세요. |

실천 · 같은 계열 안에서도 복용 시간·부작용이 달라 처방대로 드세요.

출처 · 마지막 장

# 기침이 생기는 약이 있습니다

마른기침·입술 붓기 등 몸의 변화를 살피세요.



**시작 뒤 칼륨·크레아티닌을 확인합니다**

실천 · 기침이 계속되면 진료받고, 얼굴·입술·혀가 붓거나 숨쉬기 어려우면 바로 응급실로 가세요.

## 기침이 생길 수 있는 종류

마른기침은 약 10%, 얼굴·입술이 붓는 응급 부작용은 0.1~0.7%로 보고됐습니다. 기침은 한국인에게 더 흔할 수 있습니다.

## 기침이 드문 종류

앞의 약과 혈압을 낮추는 효과는 비슷하고 마른기침은 드뭅니다. 앞의 약으로 얼굴이 부은 적이 있다면 꼭 알려 주세요.

## 두 약의 공통 주의

칼륨과 콩팥 기능을 확인해야 합니다. 임신 중이거나 양쪽 콩팥 동맥이 좁은 분에게는 쓰지 않으며, 두 계열을 함께 쓰지 않습니다.

출처 · 마지막 장

# 발목 붓기와 느린 맥박을 구분하세요

같은 칼슘차단제라도 혈관과 심장에 미치는 효과가 다릅니다.

### 혈관을 넓히는 칼슘차단제

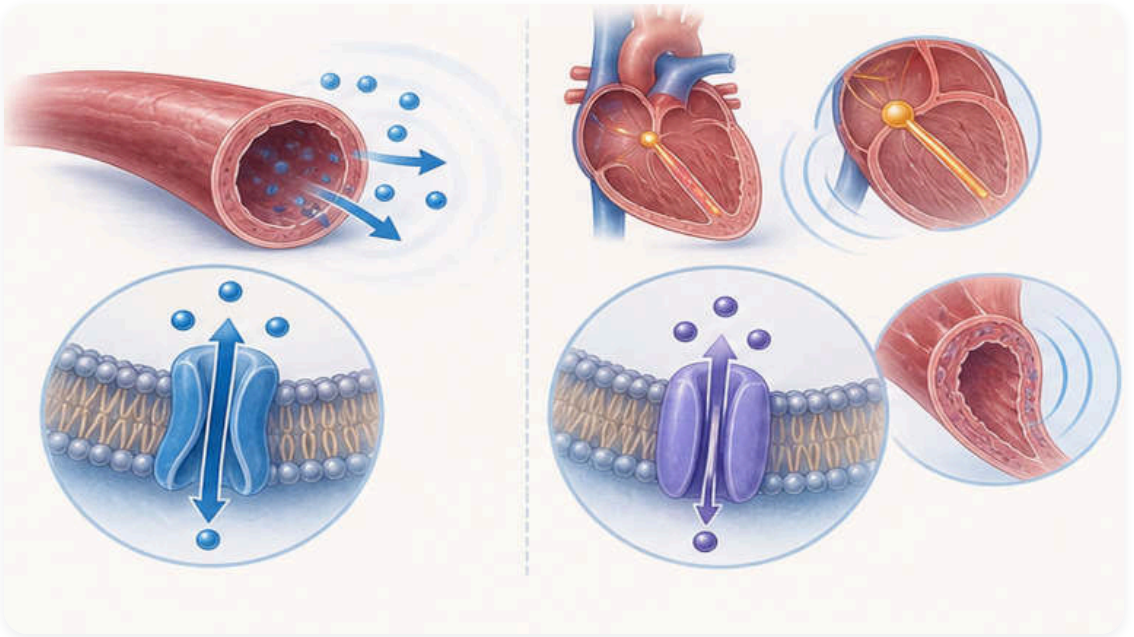
혈관을 넓혀 혈압을 낮춥니다. 발목이 붓거나 얼굴이 달아오르고, 두통이나 잇몸이 두꺼워지는 증상이 생길 수 있습니다. 증상을 기록해 의사에게 알려 주세요.

### 맥박도 늦추는 칼슘차단제

이 종류는 혈관을 넓히면서 맥박도 늦춥니다. 맥박이 너무 느려지거나 변비가 생기면 알려 주세요.

### 맥박을 늦추는 약의 주의점

심장 힘이 약하거나 심장 신호 전달에 문제가 있다면 의사에게 알려 주세요. 다른 맥박약과 함께 쓰면 맥박이 더 느려질 수 있습니다.



**발목 붓기와 느린 맥박은 약을 바꿀 때 중요한 단서입니다**

실천 · 발목 붓기나 맥박이 느려지는 증상을 진료 때 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 소변을 늘리는 약의 차이

복용 뒤 피검사로 소금·칼륨·콩팥 기능을 확인할 수 있습니다.

| 약 종류 | 몸에 머무는 시간(반감기) | 치료 중 확인할 것 | 환자가 기억할 점 |
|---|---|---|---|
| **클로르탈리돈** | 하루 12.5~25 mg · 몸에서 절반으로 줄어드는 데 40~60시간 | 다른 흔한 이뇨제보다 심장혈관 사건 차이는 없었고 칼륨이 더 낮아질 수 있었습니다. | 안내받은 날에 피검사를 받으세요. |
| **인다파미드** | 하루 1.5 mg 서방형 또는 2.5 mg · 14~18시간 | 혈당·지질 등에 미치는 영향이 비교적 적습니다. | 복용 시간을 처방대로 지키세요. |
| **히드로클로로티아지드** | 하루 25 mg · 6~12시간 | 작용 시간이 비교적 짧고 복합제에 흔히 들어 있습니다. | 약 봉투에서 성분을 확인하세요. |
| **스피로노락톤** | 세 약을 써도 혈압이 높을 때 의사가 하루 25~50 mg을 검토합니다. | 시작 전에 콩팥 기능과 칼륨을 확인합니다. | 칼륨 증가나 가슴 부위 변화가 생기면 알려 주세요. |

실천 · 이뇨제를 시작했다면 안내받은 날짜에 피검사를 받으세요.

출처 · 마지막 장

# 새 증상이 생기면 알려 주세요

발목 붓기, 기침, 어지럼, 느린 맥박을 적어 오세요.

### 기침이 생길 수 있는 약

마른기침은 약 10%에서 보고됐고 한국인에게 더 흔할 수 있습니다. 얼굴·입술·혀가 부으면 바로 응급실로 가세요.

### 기침이 드문 호르몬 억제약

기침은 드물지만 칼륨과 콩팥 기능을 확인합니다. 앞의 약으로 얼굴이 부은 적이 있다면 이 약도 신중히 정해야 합니다.

### 혈관을 넓히는 약

발목 붓기·얼굴 달아오름·두통·잇몸 변화가 생길 수 있습니다. 부종이 심하면 의사가 다른 약으로 바꿀 수 있습니다.

### 맥박도 늦추는 약

맥박이 느려지거나 심장 신호 전달에 문제가 생기고 변비가 올 수 있습니다. 심장 힘이 약한 분은 악화될 수 있어 의사에게 알려 주세요.

### 이뇨제

칼륨·나트륨·마그네슘이 낮아짐 · 요산 상승·통풍 악화 · 혈당 상승 · 광과민성. 알도스테론 차단 이뇨제(스피로노락톤 등): 칼륨 증가·여성형 유방.

### 베타차단제

느린 맥박 · 피로 · 운동능력 저하 · 발기부전 · 사지냉감. **갑작스러운 중단 금지**(갑자기 끊으면 맥박이 빨라지거나 가슴 통증이 생길 수 있음).

실천 · 새 증상이 있어도 임의로 끊지 말고 처방 의사에게 연락하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 함께 쓰면 위험한 조합

처방받는 곳이 여러 군데라면 모든 약을 알려 주세요.

### ⚠ 호르몬 억제약 두 종류를 함께 쓰지 않기

두 종류를 함께 쓰면 칼륨 상승과 갑작스러운 콩팥 손상이 늘었습니다. 당뇨병이나 콩팥병이 있으면 알리스키렌(또 다른 호르몬 억제약)도 함께 쓰지 않습니다.

### 맥박 조절형 칼슘차단제 + 베타차단제 신중

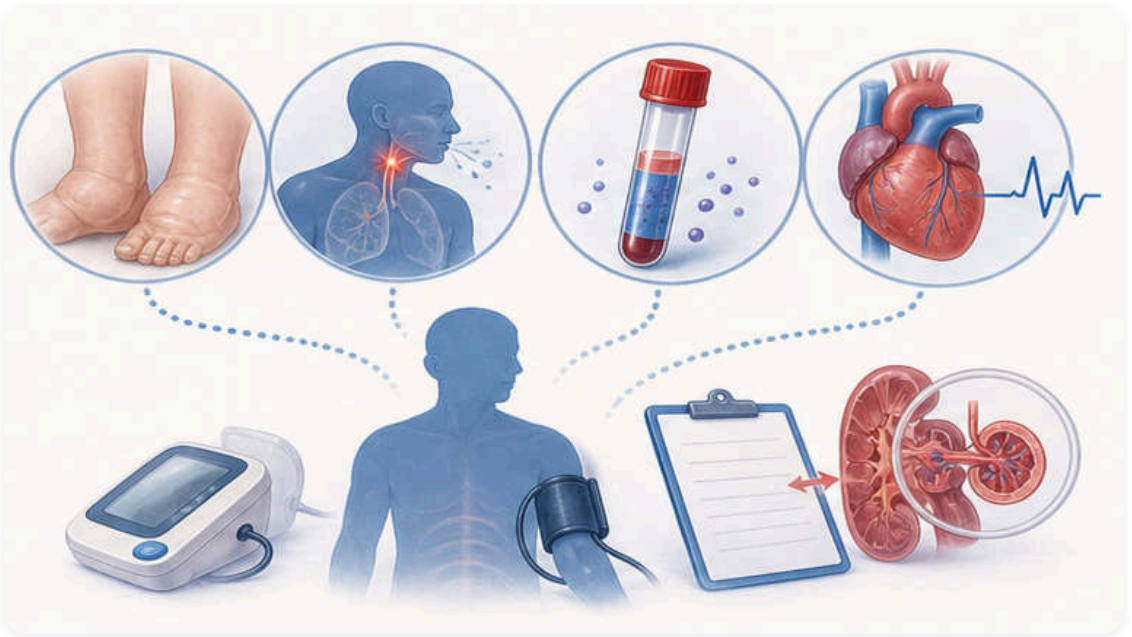
맥박이 심하게 느려지거나 심장 전기 신호 전달에 문제가 생길 수 있습니다.

### 임신 중 호르몬 억제약 금기

이 종류의 약은 태아의 콩팥에 해로울 수 있습니다. 임신 중이거나 계획 중이면 바로 의사에게 알려 주세요.

### 시작 뒤 확인

약 종류에 따라 피 속 칼륨·콩팥 기능·소금 성분·요산, 발목 붓기와 맥박을 확인합니다.



**베타차단제는 서서히 줄여 끊습니다 — 갑자기 끊으면 맥박이 빨라지거나 가슴 통증이 생길 수 있습니다**

실천 · 다른 병원 약과 임신 가능성을 처방 전에 꼭 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료 전 이 목록을 확인하세요

가정 혈압 기록과 약 목록이 약 선택에 도움이 됩니다.

### ① 혈압 기록

집에서 잰 혈압을 가져오면 약을 더할지 정하는 데 도움이 됩니다.

### ② 약을 더할 때

의사는 작용이 다른 약을 함께 쓸 수 있습니다. 스스로 더하지 마세요.

### ③ 기침 기록

마른기침이 언제 시작됐고 얼마나 계속되는지 알려 주세요.

### ④ 소변을 늘리는 약

작용 시간이 긴 약도 있습니다. 피검사로 칼륨을 확인하세요.

### ⑤ 발목이 부으면

부종을 알려 주세요. 의사가 약을 바꿀 수 있습니다.

### ⑥ 심장병도 알리기

심부전·심장혈관병·빠른 맥박이 있다면 약 선택에 중요합니다.

### ⑦ 다른 병원 약

모든 처방전을 보여 주세요. 함께 쓰면 위험한 약이 있을 수 있습니다.

### ⑧ 혈압이 계속 높으면

의사가 칼륨과 콩팥 기능을 보고 약 추가를 검토합니다.

실천 · 진료 때 약 봉투와 가정 혈압 기록을 가져오세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 혈압약 상담 때 다시 보기

QR로 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다 · 함께 드리는 혈압약 세기 안내문도 읽어 보세요.

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

혈압약을 이해하기 위한 환자 설명자료입니다. 어떤 약을 얼마나 쓸지는 함께 앓는 병과 다른 약을 종합해 담당 의사가 정합니다.

## 참고한 자료

KSH 2022 · ESH 2023 · Law 2003(BMJ) · Wald 2009(Am J Med) · ONTARGET 2008 · VA NEPHRON-D 2013 · ALTITUDE 2012 · DCP(NEJM 2022) · PATHWAY-2(Lancet 2015) · White 2011 · Heran(Cochrane 2008) · CAFE · ALLHAT · SHEP · HYVET

SCAN TO REVISIT

**진료실에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요